

04 - 04- PATHOLOGIE DU CANAL PÉRITONÉO-VAGINAL (CPV) - Pr. KAMILI

Bonjour tout le monde. Toujours dans le cadre du module des maladies de l'enfant, ce module de chirurgie pédiatrique, nous allons voir aujourd'hui la pathologie du canal péritoneal vaginal. Alors, comme objectif relatif à ce chapitre, vous êtes tenu d'expliquer le mécanisme des anomalies du canal péritoneal vaginal, de reconnaître sur les données cliniques les anomalies du CPV du garçon et de la fille.

Vous êtes également tenu de reconnaître un étranglement herniaire et le réduire médicalement. Vous devez être également capable de préciser les indications thérapeutiques devant les anomalies du CPV et d'interpréter la transillumination d'une grosse bourse. En guise d'introduction, la pathologie du canal péritoneal vaginal regroupe les hernies inguinales du garçon et de la fille, l'hyperostème de la vaginale et le kyste du cordon.

Ces anomalies couramment rencontrées chez l'enfant ont une même origine congénitale, à savoir l'absence de régression du canal péritoneal vaginal. Que dire si ce n'est que c'est une pathologie qui est fréquente en pratique quotidienne, que ce soit dans les consultations de pédiatrie ou de chirurgie pédiatrique ou du médecin généraliste, se voit surtout au cours de la première année de vie, due à la persistance plus ou moins complète du canal péritoneal vaginal. Il faut noter ici que la paroi abdominale est normale et tonique, car c'est une hernie congénitale, contrairement à celle de l'adulte qui est acquise.

Après l'avoir introduit, nous allons voir quelques notions fondamentales, puis des rappels d'embryologie et de physiopathologie, avant de voir le vif des sujets, à savoir comment faire le diagnostic positif des anomalies du canal péritoneal vaginal et conclure à la fin. Alors, c'est quoi ces notions fondamentales? Alors, c'est que ces anomalies liées à la persistance du CPV peuvent se manifester à tout âge. Le canal péritoneal vaginal, bien qu'ouvert, peut s'exprimer beaucoup plus tard qu'à la naissance.

L'association des anomalies du CPV est possible chez le même enfant. On peut voir, par exemple, une hydroscelle d'un côté, une hernie de l'autre, un kyste du cordon de l'autre côté, etc. La bilatéralité est rencontrée dans 15% des cas et peut revêtir tous les aspects.

La persistance anormale du canal péritoneal vaginal accompagne souvent une anomalie de migration du testicule dans environ 50% des cas. Le diagnostic de ces anomalies repose sur trois critères, à savoir le siège de la tuméfaction, est-il inguinal ou inguino-scrotale ou scrotale, l'état de l'orifice inguinal profond, est-il comblé ou libre, la réductibilité, et enfin les preuves de la transillumination. Le traitement de ces anomalies du CPV consiste en la suppression du CPV par voie inguinale.

Sur le plan embryologie et physiopathologie, au troisième mois de grossesse, le péritoneal abdominal

forme le CPV qui descend dans le canal inguinal et accompagne le testicule chez le garçon et le ligament rond chez la fille. La fermeture du CPV se produit soit au huitième mois, soit à la naissance ou même parfois avant l'âge de un an. La persistance du canal péritoneal vaginal peut entraîner une hernie inguinale, une hydroselle ou un kyste du cordon spermatique.

Sur le plan embryologique, on remarque ici le testicule, le gubernaculum testis, le testicule en voie de descente vers la gourse, et voilà le péritoneal avec le fascia transversalis, etc. Donc, c'est qu'au troisième mois de grossesse, le péritoneal va émettre une évagination qui va s'appeler le processus vaginalis. Ce processus vaginalis va en se creusant et vers le troisième mois, il va accompagner la descente du testicule chez le garçon et le ligament rond chez la fille.

Voilà enfin le processus vaginalis en place reliant, donc on l'appelle canal péritoneal vaginal parce qu'il relie le péritoneal à l'enveloppe vaginale du testicule, d'où sa dénomination de canal péritoneal vaginal. Donc, la régression de ce processus vaginalis va laisser comme vestige le ligament de cloquet chez le garçon et le ligament de nuque chez la fille. Voilà une coupe normale d'une bourse chez un garçon.

Donc, voici le vestige du canal péritoneal vaginal qui a régressé, c'est ce qu'on appelle le ligament de cloquet. Voici la vaginalité circulaire et toujours on voit que ce vestige reliait avant la cavité péritoneale avec l'enveloppe vaginale du testicule. Alors, un canal qui reste totalement perméable va donner une hernie inguino-scrotale, une hydroselle communicante ou une hernie de l'eau verte chez la fille.

Un canal qui reste partiellement perméable peut donner lieu soit à une hernie inguinale, soit à un kyste du cordon. Chez le garçon, le processus vaginalis, donc pour récapituler, chez le garçon, le processus vaginalis suit le gubernaculum qui l'ont testis, donc la descente testiculaire, et s'appelle le canal péritoneal vaginal. A la fin du huitième mois de vie, de la vie fœtale, le CPV se ferme complètement et laissera qu'on vestige le ligament de cloquet.

Alors, en fonction de sa perméabilité totale ou partielle, le CPV, la persistance du CPV donnera lieu soit à une hernie inguinale, soit à une hernie inguino-scrotale, soit à une hydroselle, soit à un kyste du cordon. Chez la fille, le processus vaginalis prend le nom de canal de nuque et suit le trajet du ligament rond. Nous arrivons maintenant au vif du sujet, à savoir comment faire le diagnostic des anomalies du CPV.

Nous allons prendre comme type de description la hernie inguinale non compliquée du garçon. La hernie inguinale, c'est la présentation, l'appeler communément, rencontrer en pratique courante, et puis non compliquée, parce que c'est à ce stade que vous devez faire le diagnostic et non pas au stade de complication. Alors, sur le plan anamnestique, nous devons nous acquérir de la date d'apparition, qui généralement remonte à la naissance.

Encore faut-il que les parents soient attentifs et vigilants pour pouvoir déceler l'anomalie à la naissance. Donc, on notera également, on va rechercher la fréquence des épisodes

d'engouement. Par engouement, nous voulons bien dire les moments où la hernie, par exemple, descend dans le CPV, ça s'appelle un engouement herniaire.

On cherchera les signes associés, notamment les signes digestifs. Sur le plan clinique, l'examen se fait en position debout et en position couchée. Alors, il montre une tumefaction soit inguinale lorsqu'il s'agit d'une hernie inguinale, ou inguino-scrotale lorsqu'il s'agirait d'une hernie inguino-scrotale.

C'est une hernie qui est moelleuse, indolore, expansive, réductible et avec un caractère garguillant parce que le contenu est intestinal. L'épreuve à la transhumiliation est négative. Il ne faudrait pas omettre d'examiner le côté controlatéral à la recherche d'une bilatéralité qui existe dans 15% d'écarts comme nous l'avons dit tout à l'heure.

Notez le comblement de l'orifice inguinal ici. Une hernie inguinale droite. Et là, une hernie inguinale gauche.

Comme diagnostic différentiel, ce sont surtout les autres anomalies du CVV, à savoir l'hydrocène. Mais là, l'épreuve à la transhumiliation est positive. Puis, même également, les données de la palpation, etc., font différer les choses.

Alors, le kyste du cordon, la transhumiliation est également positive. Et puis, dans le kyste du cordon, la masse est suspendue entre l'orifice inguinal et le pôle supérieur du testicule. Certains tumeurs testiculaires également peuvent prêter à confusion avec une hernie inguino-scrotale.

Mais là, le contexte est différent, etc. Alors, l'évolution de la hernie inguinale peut être émaillée d'un étranglement herniaire et qui constitue une urgence thérapeutique. Parce qu'il y va de la vitalité intestinale et de la vitalité testiculaire.

Les deux sont compromises en cas d'étranglement herniaire. Sur le plan thérapeutique, alors la chirurgie de la hernie inguinale, non compliquée, c'est une chirurgie à froid programmée. Ça consiste en la libération et la ligature du canal péretonio-vaginal par voie aminale.

La hernie inguinale s'opère donc dès que le diagnostic est posé, mais de manière programmée. Tout bondage, contention, manipulation est dénuée de tout fondement scientifique. Il s'agit d'une chirurgie ambulatoire obéissant à des principes rigoureux et bien codifiés.

Voilà la position du patient et le tracé de l'incision au niveau du pli abdominal inférieur de la région inguinale. Libération du CPV, dont le bout proximal sera ligaturé par un point de meunier à ras du péritoine. Le bout distal restera libre sans aucune suture.

Toujours après avoir ligaturé le canal péretonio-vaginal, là vient la les suture du plan sujaçant. Là, la chirurgie peut se faire aussi bien par voie conventionnelle que par voie scéioscopique. Ici, on marque la ligature du CPV par voie scéioscopique.

Qu'en est-il de la comparaison laparoscopie versus incision inguinale? La laparoscopie paraît en théorie beaucoup plus facile, nécessite plus de compétences, plus d'apprentissage de la part des opérateurs. Elle a intérêt surtout dans les formes bilatérales, dans lesquelles elle peut faire la cure des deux côtés. Et puis, les suites présentent moins d'infections de paroi.

Après avoir vu cette forme de description, nous allons passer maintenant aux formes cliniques. A savoir, la hernie étranglée, la hernie de la fille, l'hydrosel de la vaginale et le quise du corbeau. Alors, la hernie étranglée peut, c'est l'incarcération de l'once à l'intérieur du CPV à travers le canal inguinal.

Donc, elle peut soit révéler une hernie, soit compliquer une hernie qui est déjà connue. Les parents peuvent venir la première fois avec une hernie étranglée qui n'était pas connue jusque-là. L'étranglement herniaire expose un double risque, à savoir la nécrose intestinale et la nécrose testiculaire par compression du cordon spermatique.

Sur le plan anamnistique, on s'en tirera du moment des débuts, parce que l'urgence se compte en heures. Donc, la vitalité testiculaire et la vitalité intestinale se comptent en heures. Il faut chercher des signes digestifs, notamment des signes d'un syndrome occlusif, à savoir les vomissements au milieu avec arrêt du transit.

Examen clinique, on recherchera les signes d'étranglement. Alors, nous avons vu tout à l'heure les caractéristiques de cette tuméfaction inguinale ou anguloscrotales qui n'était pas compliquée. Maintenant, en cas de complication, c'est-à-dire en cas d'étranglement, la tuméfaction inguinale ou anguloscrotales devient permanente, douloureuse, irréductible, non-expansive et surtout très inflammatoire.

Une hernie anguloscrotales étranglée réalisant l'aspect d'une grosse bourse inflammatoire aiguë. Le traitement, en l'absence de syndrome occlusif, on fait une réduction par taxiste puis une chirurgie et en cas d'échec du taxiste, on passera à la chirurgie. En cas d'occlusion intestinale aiguë, c'est la chirurgie d'emblée.

La palpation des orifices hernières est systématique devant toute occlusion intestinale aiguë. Le geste qu'on appelait taxiste, c'est le fait de pousser l'anse hernière étranglée vers la cavité abdominale d'un geste prudent. C'est un geste qui nécessite l'isolement du patient dans une salle obscure, calme, après l'avoir sédaté par du Valium en intrarectale et en position de train d'Ellenbourg.

On laissera faire spontanément et en cas de non-réductibilité spontanée, on passera au taxiste, c'est-à-dire le fait de pousser cette anse hernière vers la cavité abdominale. Nous répétons toujours que ce taxiste est contre-indiqué en présence de signes d'occlusion intestinale. La hernie de la fille, deuxième forme clinique.

Le contenu hernière chez la fille peut être soit digestif, c'est-à-dire molasse, c'est la hernie

inguinale de la fille. Il peut être ovarien, dans ce cas la forme est ovoïde et réalise ce qu'on appelle la hernie de l'ovaire qui est la plus fréquente dans 80% des cas. Alors, cliniquement, la hernie inguinale de la fille réalise une masse molasse au-dessus de la grande lèvre, gargarillante et réductible.

La hernie de l'ovaire, une masse ferme de la région inguinale et de la grande lèvre. En cas de bilatéralité, attention, attention, poncez, ayez l'arrière poncé d'une anomalie du développement sexuel. Voilà, une hernie inguinale de la fille.

Et voilà, une hernie de l'ovaire droite chez une petite fille. Alors, voici une hernie de l'ovaire et vous remarquez cette couleur aubergine qui signale des ondes de nécrose. La troisième forme clinique, c'est l'hydrosel de la vaginale.

C'est quoi cette hydrosel? C'est l'accumulation de liquide en quantité anormale au niveau de la vaginale. Elle réalisera une grosse bourse chronique, indolore, elle peut être communicante ou pas en fonction de la perméabilité du canal péritonéo-vaginal. Et surtout, avec l'épreuve à la transillumination, elle est positive.

Voilà, l'épreuve à la transillumination, c'est l'application d'une source lumineuse, notamment une torche au niveau de la bourse. Vous voyez que c'est allumé et ça passe de l'autre côté. On dit que l'épreuve de la transillumination est positive.

Voilà l'aspect d'une hydrosel droite chez un petit garçon. Alors, une hydrosel droite, une hydrosel bilatérale dans cette photo. L'évolution peut être, on peut espérer, une résorption spontanée jusqu'à l'âge de 18 à 24 mois.

Donc, il est illusoire de vouloir indiquer une chirurgie avant ces deux dates. Parce qu'il y a toujours l'espoir d'une résorption spontanée. Donc, le traitement se fait en cas d'indication selon la même technique chirurgicale que pour la hernie inguinale.

La chirurgie se fait à partir de l'âge de 2 ans, pour certains à partir de 3 ans. Donc, elle est indiquée en cas de non-résorption spontanée, en cas de gêne fonctionnel ou esthétique par le volume. Et puis, ça consiste en la fermeture du canal péritonéo vaginal par voie inguinale.

Attention, attention, jamais de ponction d'une hydrosel ou d'un kyste du cordon. Parce qu'il n'y a que le risque de blessure du cordon. Et puis, le risque d'ensemencement microbien.

Et vous le savez, si on fait une ponction, on ne va pas traiter la cause. Et le canal péritonéo vaginal qui va rester en place va toujours ramener du liquide. D'accord? Le kyste du cordon, comme quatrième forme clinique, résulte de l'oblitération bipolaire du CPV, réalise une lésion suspendue.

Donc, c'est une tumeur suspendue entre l'orifice inguinal qui est libre et le pôle supérieur des testicules, lequel les testicules restent palpables. C'est une tumeur action le long du cordon qui

est réunitante, positive à la transillumination. Et là également, on a un espoir de résorption spontanée jusqu'à l'âge de 18 à 24 mois.

Alors, la lésion suspendue. Et puis, on a ici la transillumination qui est positive. Alors, l'orifice libre, la tumeur action à mi-chemin entre l'orifice qui est libre et le pôle supérieur des testicules.

Le traitement, donc toujours possibilité de résorption spontanée jusqu'à l'âge de 18 à 24 mois. Donc, ne pas opérer avant ces dates. La chirurgie se fait à partir de l'âge de 2 ans et pour certains encore jusqu'à l'âge de 3 ans.

Elle consiste en la fermeture des canaux péritoniaux vaginaux par voie inguinale. Et jamais de ponction également là aussi parce qu'on risque de blesser le cordon somatique. Donc, en conclusion, que pouvez-vous nous dire si ce n'est que toute tumeur action inguinale, inguino-scrotale ou inguino-labiale chez l'enfant est a priori une hernie par perméabilité persistante du canal péritoniaux vaginal appelé également processus vaginalis.

Toute hernie inguinale comporte un risque évolutif d'étranglement et met en jeu la vitalité des testicules. Le diagnostic des anomalies du CPV est clinique. Aucun examen complémentaire n'est nécessaire et vous l'avez vu tout au long de ce chapitre, on n'a jamais parlé d'examen complémentaire.

Et finalement, la palpation des orifices hernières doit être systématique devant toute occlusion intestinale aiguë chez l'enfant ou chez l'adulte. Donc, devant toute occlusion intestinale aiguë, ayez le réflexe d'examiner les orifices hernières parce que vous pouvez tomber sur un étranglement hernière.